

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS 22231569097 | 838

IBERÊ BARBOSA LIMA

IDADE: 42 PESO: 80 ALTURA: 172 PROFISSÃO: Adv.
SINTOMAS: memória - Tem delir. - Irritabilidade - Refluxo na
QUEIXAS: Rorco (3 meses)
MEDICAMENTOS: Suplementos.
Uso de Hormônio
MÉDICO: Dra Catharina
MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N
EXERCÍCIO FÍSICO: Sim TODOS OS DIAS
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:
HORA QUE DORME: 00:00 HORA QUE ACORDA: 09:00
COCHILLO () SIM (X) NÃO DORME ACOMPANHADO () SIM (X) NÃO () EVENTUAL
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA () NÃO (raro) causa a tarde
FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 0X
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 40.2 SPO2: 77%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:
CIRURGIAS: (S) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA () CARDÍACA
() ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS
04/04/24 - Avaliação. Jua
11/04/24 P= 11 cmH₂O
IAH= 18.5 efv
m. de uso: 4h40'
Fuga= 24.7. Jua.
25/04/24 P= 11 cmH₂O (5u.dias) / 20d. P= 11 cmH₂O
IAH= 3.8 efv IAH= 8.3 efv
m. de uso= 7h41' m. de uso= 6h40'
22/05 P= 11 cmH₂O
24 IAH= 1.9 efv
m. de uso: 7h26m Bem adaptado
fuga: 32.8 l/min Natasha
27/06 P= 11 cmH₂O
24 IAH= 0.8 Jua
m. de uso: 7h Natasha
05/09 P= 11 cmH₂O
24 IAH= 1.1 efv Bem adaptado
m. de uso: 7h45' Natasha
fuga: 23.6 l/min

27/03/25

P=11 cmH₂O

IAH=0,7 e/h

vm de uso: 7h45'

fluxo: 25,9 l/m

troco filtro da almofada

Troco filtro do aparelho

Natacha

26/06/25

P=11 cmH₂O

IAH=0,6 e/h

mdc uso: 7h45'

fluxo: 27,8 l/m

Troco filtro do aparelho

Natacha

Shine B. Inc

Quando o paciente chega com
queixa de SD. de queixa sua
clínica após exames e CNP
para exames e adaptações de CNP

Aty

DRA. CATHARINA SOARES DE ANDRADE
Otorrinolaringologista
CRM: 74458

DR. ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Iberê Barbosa Lima

EXAME nº: 5565

SOLICITADO POR: Dra. Catharina Soares de Andrade

DATA: 03/02/2024

IDADE: 42 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h34min e concluído às 05h53min. A latência para o sono foi de 4 minutos e a latência para o estágio REM, de 87 minutos. O tempo total de sono foi de 355,5 minutos (05h55min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 80,9%. A distribuição do sono mostrou 7,6% de estágio 1, 59,9% de estágio 2, 18,8% de estágio 3 e 13,6% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 79,5 minutos em vigília, ocorreram 58 microdespertares (índice: 9,8/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 40,2/hora, sendo 2 apneia/hora e 38,1 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 40,7/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 96%, sendo a saturação média de 93% e a mínima de 77%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (40,2/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (40,7/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 55; máxima: 72 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de médio a alto.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 4 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava normal (87 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 80,9%; normal: 85% ou acima), mas o índice de índice de microdespertares (9,8/hora; normal até 15/hora) manteve-se no limite da normalidade - observei o padrão alternante cíclico (PAC) no estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 2 (59,9%; normal: 45-55%) e 3 (18,8%; normal: 10-12%), e a redução do estágio REM (13,6%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 1 (7,6%; normal: 8-10%) permaneceu no limite inferior da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 7 (normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

Telefone: 474-0005/110-52

Endereço: Centro - São José dos Campos - SP

Telefone: 474-3541/2093/3943-2162



Clínica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Iberê Barbosa Lima

EXAME nº: 5565-2 CPAP

SOLICITADO POR: Dra. Catharina Soares de Andrade

DATA: 06/03/2024

IDADE: 42 anos

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

Comentários:

Exame iniciado às 21h56min e concluído às 06h08min. A latência para o sono foi de 1 minuto e a latência para o estágio REM, de 60 minutos. O tempo total de sono foi de 474 minutos (07h54min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 96,2%. A distribuição do sono mostrou 3,6% de estágio 1, 44,3% de estágio 2, 26,5% de estágio 3 e 25,6% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 17 minutos em vigília, ocorreram 55 microdespertares (índice: 7/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 6,1/hora, sendo 1 apneia/hora e 5,1 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 6,1/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 93%, sendo a saturação média de 94% e a mínima de 81%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara nasal Mirage Activa large (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 10 cm de H₂O.

Registraram-se aumentos leves dos índices de apneia/hipopneia (6,1/hora; índice leve: 5 a 15/hora) e de distúrbio respiratório (6,1/hora), ritmo cardíaco sinusal e episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina. As frequências cardíacas foram: mínima: 49; máxima: 65 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 1 min; normal até 30 min) – ele ingeriu um comprimido de zolpidem 10 mg às 21h30min. A latência para o estágio REM estava encurtada (60 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (96,2%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (7/hora; normal até 15/hora) mantiveram-se nos limites da normalidade. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 3 (26,5%; normal: 10-12%) e REM (25,6%; normal: 20%), e a redução dos estágios 1 (3,6%; normal: 8-10%) e 2 (44,3%; normal: 45-55%).

Sem movimentos periódicos de membros.

Avenida Dr. João Guilhermino, 474, sl 51 e 52
Ed. Office Tower - Centro - São José dos Campos
Tel: (12) 3913-2162 | (12) 3941-2449 | (12) 99622-8008

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69730